

العمر(تاريخ الميلاد) : 26-11-1969 المهنة : ربه منزل

التوقيع: (_____)

التعليق على التشخيص : -----

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

----- / د ----- / د ----- / د. | ----- / د. |

التشخيص النهائي : _____
 خطة العلاج : _____
 المستشفى : _____
 قسم : _____
 جهة العلاج : _____
 ملاحظات : _____
 نفقات : _____

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: نجوى عبدالعزيز احمد نوح National ID: 26911261700507	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

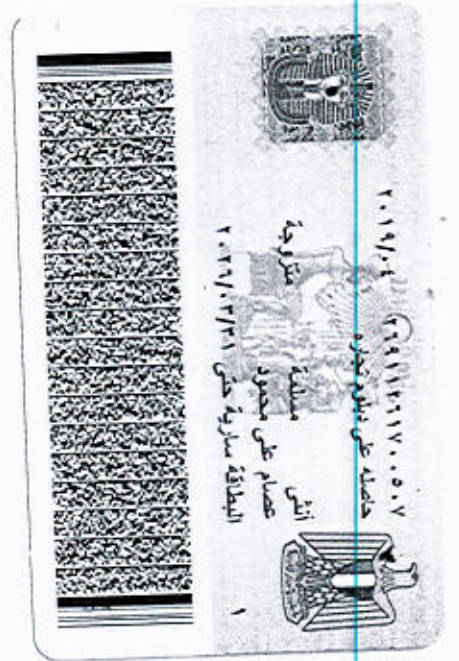
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Contrast-enhanced CT of chest, abdomen and pelvis.

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



B/4



Name: نجوي عبدالعزيز احمد نوح		
MR. : 4808		
Detailed Medical Report		
		السيد
تخية طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه		
The patient is a 57-year-old individual with a history of post-mastectomy breast cancer, diagnosed as left-side infiltrating ductal carcinoma, grade II, ER 8/8, PR 5/8, HER2 negative, clinical stage cT2N2. Neoadjuvant aromatase inhibitor therapy was initiated due to elevated liver function tests, followed by a left-triple-quadrantectomy with wide local excision and axillary lymph node dissection, resulting in a ypT2ypN3 pathological stage in 2022. Adjuvant chemotherapy with paclitaxel (Taxol) and cyclophosphamide (Endoxan) was administered for 18 weeks, after which the patient received post-operative radiotherapy. Since February 2023, the patient has been on adjuvant aromatase inhibitor therapy with Arimidex, prescribed for a 3-month course, with the next follow-up scheduled after completion of this period.		
تحريرا في ,		
	التاريخ :	20-09-2026
	الوقت :	عزه احمد عبيد الغنى
		الطبيب المعالج :
يعتمد ,		



Patient Name : الأستاذة / نجوى عبدالعزيز احمد نوح	Request No. : 13002781
Patient No. : 26911261700501	Request Date : 12/05/2022
Path No. : 1224/22	Verification Date : 18/05/2022
Sex : Female	Financial Category : اورام دار السلام - اقتصادي
Age : 52 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : Ali mostafa

Pathology Report

Clinical Data:

Left breast cancer, on Hormonal therapy.

Nature of the specimen:

Left WLE with extra lower margin, nipple surgical margin, axillary dissection.

Gross Examination:

Four specimens were received designated as:

- 1-Left WLE measuring 10x7x3 cm, No skin covering. Cut section revealed an ill-defined firm grayish white mass measuring 2.5x2x2 cm, located 2 cm, 3cm, 1.5cm, 0.1cm, 0.5cm, 1cm from lateral, medial, superior, inferior, superficial and deep margins . respectively. Rest of breast showed fibrotic rubbery grayish white cut section.
- 2- Extra lower margin: Fibrofatty tissue piece; 6x4 cm. Free from gross induration.
- 3- Nipple resection margin: Three fibrofatty tissue pieces measured collectively 3x3 cm. Totally submitted.
- 4- Axilla; 10x7 cm. entangling 15 nodules, measured up to 4.5 cm in diameter.

Microscopic examination:

- Histological type: Invasive duct carcinoma, GIII
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): G (3+3+2)
- Angioinvasion: yes
- Ductal carcinoma in situ: No
- Tumor extent
 - o Number: 1
 - o Size: 2.5 x 2 x 2 cm
 - o Skin involvement: No
- Lymph nodes : 15/15 with extracapsular extension
- Resection Margins: Free all margins, including nipple and extra-lower surgical margin).

Verified by :

Patient Name : الأستاذة / نجوى عبدالعزيز احمد نوح
Patient No. : 26911261700501
Path No. : 1224/22
Sex : Female
Age : 52 Y
Referring Doc :

Request No. : 13002781
Request Date : 12/05/2022
Verification Date : 18/05/2022
Financial Category : اوراق دار السلام - اقتصادي
Department : Out Patient
Registered by : Ali mostafa

Pathology Report

- Histologic response to therapy: Partial Pathological response
- Additional pathologic findings: NA

Diagnosis:

Left breast cancer, Left WLE with extra lower margin, nipple surgical margin, axillary dissection ;
Invasive duct carcinoma, Grade III.
Partial Pathological response.
Free all margins, including nipple and extra-lower surgical margin .
Positive lymphatic tumor emboli.
Positive lymph nodes (15/15) with extra-capsular extension.
Stage: ypT2 ypN3.

Prof. Aml Hareedy
Dr. Walaa Ghonaim

Printing

Verified by :

Printing By : marwa m...
marwa m...

Printing Date : 18/05/2022 12:06:50

Page 2 of 3

مركز الباثولوجي - مبنى (45) - طابق الأرض - مستشفى قصر العيني - القاهرة - مصر
House No. (45) - First Floor Building No. 987, Nile Corridor - Near El Qadima, Cairo, Egypt



MDT FORM

2022/1/12

Name	فوزية محمد	MRN	6077 / 101
Age	52y	ID	679110711000
Menopausal status	(premenopausal) - (irregular)	Phone	1109805011
OCP	(no)	marital status	married
Co morbidity	Family history		
Clinical Data			

Bx:	IOC, G5	R	L
ER:	8/8	PR:	5/8
HER2:	-ve	Ki67:	50%
Sonomammography:		T ₂ N ₂ M ₀ multicentric	
Mets Workup:		Initial	
pBT/CT 1/9/2022		(no mets)	

Recommendations:

D₂ lobular intrahepatic cholestasis
T/D bilirubin 3/2.8, the patient started neoadj AI
In 8 months followed LT CBS + AC 11/5/2022. (Senara)
- IOC, G5
- partial pathological response
- free surgical margins, free lymphatic tumor emboli
- free (N₂) 15/15 (T₂N₃)

MDT OUTCOME & PLAN

1) Full G5 + liver enzymes.
2) T₂ "E taxol weekly" 60mg/m² (60mg/m²)
liver enzymes & clinical exam.

SIGNATURE			
MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY



DMS

عبد العزيز احمد توفيق
 ١٦ مشروع طرطوس منطقة ٣
 حوران - القنطرة

